

Spirala wypalenia i uzależnienia

Wypalenie zwiększa 2–3-krotnie ryzyko uzależnień. Workaholizm sam jest uzależnieniem — które społeczeństwo nagradza.

CZAS: 10 min screeningu **REALIZACJA:** ciągła ocena

ŹRÓDŁO: Ahola i in. (2006, N = 3276); Robinson (2014, „Chained to the Desk”); Andreassen i in. (2012, PLoS One, *Bergen Work Addiction Scale*)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **dwa kierunki spirali**: wypalenie → używki (alkohol, leki, jedzenie jako regulacja); workaholizm → wypalenie (kompulsywna praca jako uzależnienie). W sekcji 02 — **workaholizm: paradoks społeczny**: dlaczego najtrudniej go rozpoznać. Sekcja 03 — **screening trzech obszarów** (AUDIT-C, leki, *Bergen Work Addiction Scale*). Sekcja 04 — twoje obserwacje, plan na 2 tygodnie i decyzja o konsultacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wypalenie i uzależnienia tworzą **dwukierunkową spiralę**. Kierunek 1: wypalenie prowadzi do uzależnień. Ahola i in. (2006, fińskie badanie populacyjne, N = 3276): wypalenie zawodowe zwiększa ryzyko zaburzenia związanego z używaniem alkoholu (ang. *alcohol use disorder*) **2–3-krotnie**. Mechanizm: wyczerpanie emocjonalne + cynizm + brak alternatywnych strategii regulacji → sięganie po substancje jako *samoleczenie*. Alkohol, leki nasenne, leki uspokajające, kofeina, energetyki, jedzenie, ekrany — wszystkie pełnią funkcję doraźnej regulacji wyczerpania. Maskują problem, nie rozwiązują go. Kierunek 2: workaholizm prowadzi do wypalenia. Andreassen i in. (2012, PLoS One): **workaholizm to kompulsywne zaangażowanie w pracę mimo negatywnych konsekwencji** — koreluje z wypaleniem ($r = 0,52$), problemami zdrowotnymi ($r = 0,38$) i konfliktami rodzinnymi ($r = 0,45$). Workaholizm nie jest „pracowitością” — to uzależnienie behawioralne (jak hazard, kompulsywne kupowanie, kompulsywne korzystanie z ekranów). **Paradoks społeczny**: workaholizm jest jedynym uzależnieniem, które kultura *nagradza* (awanse, pieniądze, pochwały „pracowity, oddany”), co radykalnie utrudnia rozpoznanie — przez samego pacjenta, przez bliskich, przez klinicystę. Konsekwencja kliniczna: *przy współistnieniu wypalenia z używaniem substancji lub workaholizmem — interwencje burnout same nie zadziałają*; „leczenie” odbywa się przez substancję lub kompulsję, relapsy nieuniknione bez równoległej pracy nad obydwojema.

01 Dwa kierunki spirali

KIERUNEK 1 · WYPALENIE → UŻYWKI

Wyczerpanie wymaga regulacji. Bez alternatywnych strategii sięga się po: alkohol (ang. *nightcap*, wieczorne picie „żeby zasnąć”), leki nasenne/uspokajające, kofeinę (4+ kawy dziennie), energetyki, jedzenie (sięganie po cukier wieczorem), ekrany (przewijanie do północy). Wszystkie maskują wyczerpanie. Żaden go nie regeneruje.

KIERUNEK 2 · WORKAHOLIZM → WYPALENIE

Praca jako kompulsja, nie wybór. Andreassen i in. (2012): *kompulsywne zaangażowanie w pracę mimo negatywnych konsekwencji*. Wieczory, weekendy, urlopy — z laptopem. Sprawdzanie maili w toalecie. Niemożność „wyłączenia się”. Lęk, gdy nie pracuje.

Korelacje (Andreassen i in., 2012): wypalenie $r = 0,52$; problemy zdrowotne $r = 0,38$; konflikty rodzinne $r = 0,45$.

02 ? Workaholizm — paradoks społeczny

Workaholizm jest **jedynym uzależnieniem, które kultura nagradza**. Hazardzistę widać. Alkoholika widać. Workaholika — chwali się: „*oddany, pracowity, zaangażowany, zawsze dostępny*”. To radykalnie utrudnia rozpoznanie — przez samego pacjenta („nie jestem przecież uzależniony, ja po prostu pracuję!”), przez bliskich („ale on/ona tyle robi dla nas”), przez klinicystę („to nie problem, to wręcz zaleta”).

Rozróżnienie: pracowitość = praca jako *jedna z aktywności*, zaangażowanie + radość, możliwość wyłączenia. Workaholizm = praca jako *kompulsja*, lęk przy nieobecności pracy, niemożność wyłączenia, postępujące szkody zdrowotne i relacyjne mimo świadomości. **Test prosty:** co się stanie z twoim samopoczuciem, jeśli przez tydzień nie będziesz pracował/-a w ogóle? Jeśli odpowiedź brzmi „*doświadczę silnego lęku, niepokoju, poczucia braku wartości*” — to nie jest pracowitość.

03 ☉ Screening trzech obszarów

1 · ALKOHOL (AUDIT-C)

Jak często pijesz alkohol? (0 = *nigdy*, 4 = *codziennie*)

Ile drinków dziennie wtedy? (0 = 1-2, 4 = 10+)

Jak często ≥ 6 drinków przy jednej okazji? (0 = *nigdy*, 4 = *codziennie*)

Wynik ≥ 4 (M) lub ≥ 3 (K):
zalecane skrócone interwencje.

2 · LEKI / SUBSTANCJE

Leki nasenne — częstotliwość, dawka, kto przepisał (jeśli przepisał).

Leki uspokajające (benzodiazepiny) — czy stale, czy doraźnie.

Kofeina — liczba kaw/dzień, energetyki.

Inne substancje psychoaktywne — szczerze, bez oceniania.

3 · WORKAHOLIZM (BERGEN)

Bergen Work Addiction Scale (7 pytań — Andreassen i in., 2012). Każde 1-5:

1. Myśli o pracy zajmują dużo czasu nawet poza nią.

2. Pracuję, by zmniejszyć poczucie winy / lęku.

3. Pracuję tyle, że szkodzi to zdrowiu.

4. Inni mówią, żebym zwolnił/-a — ignoruję.

5-7. Inne kompulsywne wskaźniki.

4+ punktów w ≥ 4 pytaniach = wskazana konsultacja.

04 ✎ Mój audyt i plan na 2 tygodnie

CZYM NAJCZĘŚCIEJ REGULUJĘ WYCZERPANIE

— alkohol wieczorem, kofeina rano, leki, jedzenie, ekrany, kompulsywne sprawdzanie pracy

CZY POJAWIA SIĘ LĘK, GDY NIE PRACUJĘ

— wieczorem, na urlopie, w weekend; jaki dokładnie objaw

MÓJ EKSPERYMENT NA 2 TYGODNIE

— jedna zmiana w jednym z 3 obszarów (np. „2 wieczory w tygodniu bez alkoholu”, „kawa max 2× dziennie”, „weekend bez maila”)

DECYZJA O KONSULTACJI

— czy wynik screeningu wskazuje na potrzebę rozmowy z lekarzem, terapeutą uzależnień, lub grupą wsparcia (AA, NA, WA)

Klucz: jeśli interwencje *burnout* nie działają — szukaj ukrytego regulatora. Pacjent pracujący nad granicami, snem, regeneracją, ale wciąż wyczerpany, często ma ukryty workaholizm lub używanie substancji, które jest niewidoczne nawet dla niego samego. Pierwsza interwencja: **nazwanie tego, co się dzieje**, bez wstydu i bez bagatelizowania. Przy współistnieniu — interwencje równoległe: wypalenie + uzależnienie/workaholizm. Bez tego — relapsy są regułą, nie wyjątkiem.

△ Jeśli rozpoznajesz u siebie zaburzenia używania substancji — konsultacja z lekarzem (interna, psychiatra) i/lub terapeutą uzależnień. Nagłe odstawienie alkoholu lub benzodiazepin po przewlekłym używaniu może być groźne medycznie — wymaga nadzoru. Linia 116 123 (Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym), telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym: 801 199 990.